

약은 시작점, 생활은 엔진

마운자로·위고비 치료를 시작하기 전, 기대효과·안전확인·목표설정을 먼저 맞춥니다. 체중계 숫자보다 중요한 것은 근육과 대사 건강입니다.

약은 식욕을 낮추고 포만감을 돕는 도구입니다

약이 식사량을 줄여주더라도, 무엇을 먹고 어떻게 움직일지는 여전히 치료의 중심입니다.

마운자로·위고비는 주 1회 주사로 식욕과 포만감 신호에 영향을 줍니다. 하지만 감량의 질은 단백질, 근력운동, 수면, 추적진료가 결정합니다.

ROLE

도움 받는 부분

허기와 과식을 줄이고, 작은 식사에도 포만감을 느끼도록 돕습니다.

LIMIT

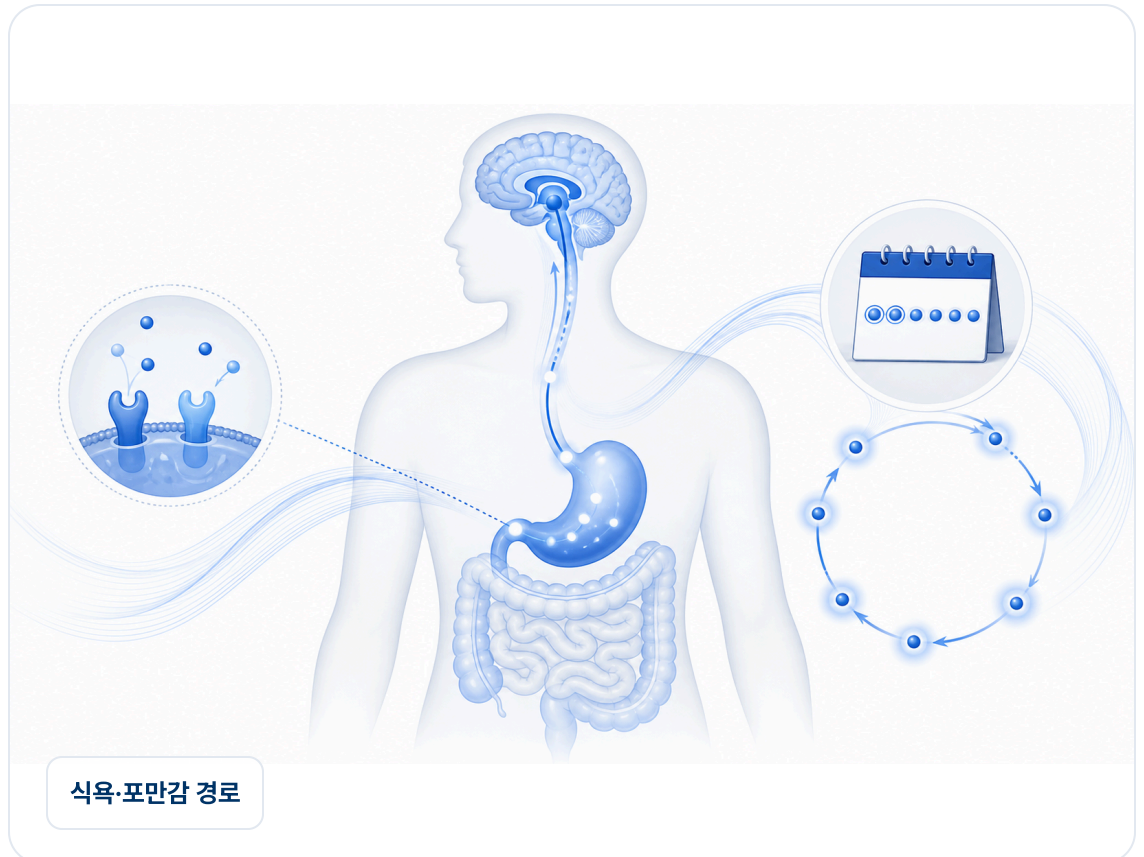
약이 못 하는 부분

근육 보존, 식사 선택, 탈수 예방, 장기 유지 습관은 환자 행동이 필요합니다.

GOAL

목표 재정의

숫자 감량보다 허리둘레, 혈압, 혈당, 지방간 위험 개선을 같이 봅니다.



첫 처방 전에는 기준선을 남깁니다

체중만 재면 반쪽입니다. 허리둘레, 혈압, 혈액검사, 복용약을 같이 봐야 안전합니다.



치료 전 상태를 기록하면 정체기와 부작용을 해석하기 쉬워집니다.
특히 당뇨약을 함께 쓰는 분은 저혈당 위험도 확인합니다.

BODY

체중·허리둘레

매주 같은 조건으로 체중을 보고, 허리둘레는 월 1회 확인합니다.

LAB

혈당·간·신장·지질

당뇨, 지방간, 신장기능, 지질 상태를 치료 전후로 비교합니다.

MEDS

복용약 검토

인슐린·설폰요소제, 이뇨제, 위장관 약은 증상과 함께 조정이 필요할 수 있습니다.

용량은 천천히 올리는 것이 치료입니다

빠른 증량은 감량이 아니라 오심·구토·탈수로 이어질 수 있습니다.

두 약 모두 보통 낮은 용량에서 시작해 단계적으로 올립니다.
속도보다 **견딜 수 있는 치료**가 더 오래 갑니다.

WEGOVY

위고비

0.25 mg 주 1회로 시작해 보통 4주 간격으로 증량합니다. 유지용량은 처방에 따릅니다.

MOUNJARO

마운자로

2.5 mg 주 1회로 시작하고, 4주 이후 5 mg 이상 단계 증량을 고려합니다.

RULE

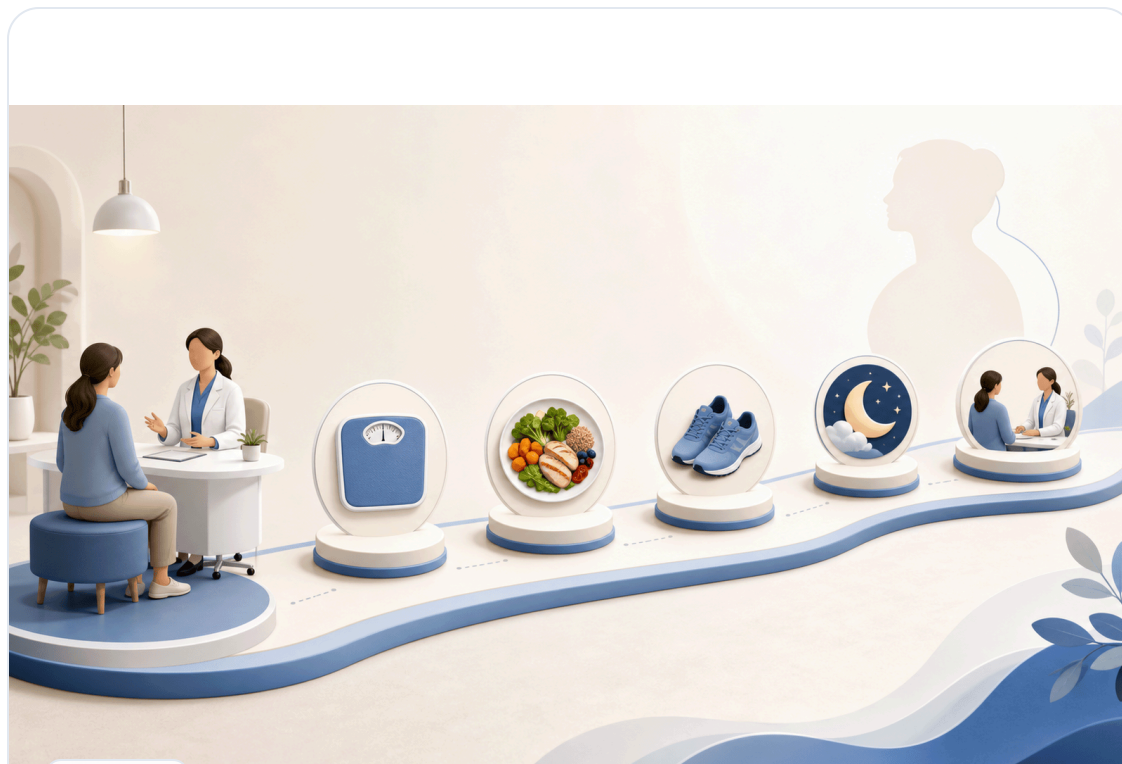
증상 우선

심한 오심·구토·설사·식사불가가 있으면 증량보다 조절이 먼저입니다.



감량 이후를 먼저 설계합니다

치료의 성공은 몇 kg 감량보다, 감량한 몸을 유지할 수 있는 루틴입니다.



장기 계획

초기부터 유지 전략을 넣어야 요요를 줄입니다. 매주 체중, 매일 단백질, 주 2회 근육운동, 충분한 수면이 기본입니다.

TRACK

주 1회 기록

매일 재는 것보다 같은 요일·같은 시간의 주간 평균을 봅니다.

MUSCLE

근육 보존

감량 속도가 빠르면 근육 손실이 커질 수 있어 단백질과 근육운동을 같이 갑니다.

FOLLOW-UP

진료 연결

부작용, 정제기, 약 중단 계획은 혼자 판단하지 않고 진료에서 조정합니다.

이번 회차는 기록부터 시작

첫 주는 몸의 반응을 관찰하고 기준선을 남기는 시간이 가장 중요합니다.

01 처음 목표는 **빠른 감량**보다 안전한 시작입니다.

02 기준선 기록은 정체기와 부작용 해석의 기준이 됩니다.

03 증량은 정해진 스케줄보다 **몸이 견디는지**가 먼저입니다.

04 약은 도구이고, 유지 루틴이 치료의 본체입니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요